Op. Dr. Murat Ayata
Kulak Burun Boğaz
Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı

Op. Dr. Murat Ayata Muayenehanesi
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez / Kırklareli
Tel: 0288 502 50 20 · WhatsApp: 0555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU

Otoplasti

Kepçe kulak düzeltme ameliyatı

Değerli hastamız, bu form size önerilen işlem hakkında bilmeniz gerekenleri **sade ve anlaşılır** bir dille anlatmak için hazırlanmıştır. Amacı sizi korkutmak değil, kararınızı **bilgiye dayanarak ve özgürce** vermenize yardımcı olmaktır.

Formu acele etmeden okuyunuz. Anlamadığınız her noktayı hekiminize sorunuz. Hekiminiz sizin durumunuza özel riskleri ayrıca sözlü olarak da açıklayacaktır. Onay vermek ya da vermemek tamamen sizin hakkınızdır.

HASTA VE İŞLEM BİLGİLERİ

Adı Soyadı: _____ Doğum tarihi: _____

T.C. Kimlik / Pasaport: _____ Dosya / Protokol No: _____

Telefon: _____ Bilgilendirme tarihi: _____

Planlanan işlem tarihi: _____

Form hastaya ilk iletildi (tarih / e-posta, WhatsApp, elden): _____

İşlemi yapacak ve bilgilendiren hekim: **Op. Dr. Murat Ayata**

İşlemin yapılacağı sağlık kuruluşu: _____

Taraf: ☐ Sağ ☐ Sol ☐ İki taraf

Anestezi şekli: ☐ Genel anestezi ☐ Lokal anestezi ☐ Lokal anestezi + sedasyon

Düzeltilecek bölümler / hastanın beklentisi: _____

1 Durumunuz ve işlemin amacı

Kepçe kulak, kulak kepçesinin başa göre normalden daha dik açıyla öne doğru durması veya kulak kıkırdağındaki doğal kıvrımın (antiheliks) gelişmemiş olmasıdır. Genellikle doğuştandır, sağlığa zararı yoktur ve işitmeyi etkilemez. Ancak özellikle çocukluk ve ergenlik döneminde alay edilme, özgüven kaybı ve sosyal kaygıya neden olabilir.

Otoplastinin amacı kulakların başa daha yakın, **doğal görünümlü** ve iki taraf arasında olabildiğince **dengeli** hâle gelmesini sağlamaktır. Kulak kepçesi 5–6 yaş civarında erişkin boyutunun büyük kısmına ulaştığı için ameliyat **5–6 yaşından itibaren** yapılabilir; okul çağından önce yapılması çocuğun sosyal açıdan etkilenmesini önleyebilir. Çocuğunuz ameliyat edilecekse, onun da isteğinin ve hazır olup olmadığının dikkate alınması önemlidir.

2 İşlem nasıl yapılır?

Ameliyat ameliyathane koşullarında yapılır. Çocuklarda genellikle genel anestezi, erişkinlerde lokal anestezi (gerekirse sedasyonla birlikte) veya genel anestezi tercih edilir.

1. **Planlama ve işaretleme:** Kulakların başa olan uzaklıkları ölçülür, fotoğraflanır ve yeni kıvrımın yeri işaretlenir.
2. **Kesi:** Kulağın **arka yüzünde**, kulak ile baş arasındaki doğal kıvrıma yakın yerde, cilt içinde bir kesi yapılır. Bu iz kulak arkasında kaldığı için dışarıdan genellikle görünmez.
3. **Kıkırdağın şekillendirilmesi:** Kulak kıkırdağına kalıcı dikişlerle yeni bir kıvrım (antiheliks) oluşturulur. Gerekirse kıkırdak inceltilir veya hafifçe çizilerek yumuşatılır.
4. **Kulağın başa yaklaştırılması:** Kulak kepçesinin derin çanak kısmı (konka) büyükse küçültülür veya dikişlerle kafatası arkasındaki dokuya sabitlenir. Kulak memesi de öne doğru duruyorsa düzeltilir.

Op. Dr. Murat Ayata Muayenehanesi
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez / Kırklareli
Tel: 0288 502 50 20 · WhatsApp: 0555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

5 **Kapatma ve sargı:** Cilt dikişlerle kapatılır. Kulakların yeni şeklini koruması ve kan toplanmasını önlemek için başa yumuşak, hafif baskılı bir sargı uygulanır.

ANESTEZİ	TAHMİNİ SÜRE	HASTANEDE KALIŞ / TABURCULUK
Çocuklarda genel anestezi; erişkinlerde lokal anestezi ± sedasyon veya genel anestezi	Yaklaşık 1–2 saat (iki taraf)	Genellikle aynı gün taburculuk

3 Beklenen faydalar ve başarı şansı

- Kulakların başa daha yakın ve doğal görünmesi
- İki kulak arasında daha dengeli bir görünüm
- Görünüme bağlı sosyal kaygının ve alay edilmenin azalması, özgüvene katkı

Hastaların ve ailelerin büyük çoğunluğu sonuçtan memnun kalır. Kulak kıkırdağı esnek bir doku olduğu için, yayınlarda hastaların yaklaşık **100'de 5–10'unda** kulağın kısmen tekrar öne doğru açılabildiği ve düzeltme ameliyatı gerekebildiği bildirilmektedir. İki kulak arasında birkaç milimetrelik farklar normal kabul edilir.

4 Diğer tedavi seçenekleri

- **Ameliyat olmamak:** Kepçe kulak sağlık sorunu yaratmadığı için ameliyat zorunlu değildir.
- **Yenidoğan döneminde kalıplama (splint):** Kulak kıkırdağı doğumdan sonraki ilk birkaç hafta çok yumuşak olduğundan özel kalıplarla şekillendirilebilir; bu dönem geçtikten sonra etkili değildir.
- **Saç modeliyle kamuflaj:** Kulakları örten saç modelleri görünümü gizleyebilir.
- **Kesisiz / iplikle düzeltme teknikleri:** Seçilmiş, yumuşak kıkırdaklı hastalarda küçük kesilerle yapılabilir; tekrarlama oranı klasik ameliyata göre daha yüksek olabilir.

5 İşlem yapılmazsa ne olur?

Ameliyat yapılmazsa kulakların şekli değişmeden kalır; zamanla kendiliğinden düzelmez. Kepçe kulak sağlık açısından bir tehlike oluşturmaz; ameliyat kararı tamamen görünüme ve kişinin (çocuklarda çocuğun ve ailenin) isteğine bağlıdır.

Önerilen işlemi kabul etmeme, ertelemek isteme veya ikinci bir hekim görüşü alma hakkınız vardır. Bu kararınız, size sunulan diğer sağlık hizmetlerini hiçbir şekilde olumsuz etkilemez. Verdiğiniz onayı, işlem başlamadan önce istediğiniz zaman geri alabilirsiniz; ancak işlem başladıktan sonra tıbben durdurulması sakıncalı olabilecek aşamalar olabileceğini de bilmenizi isteriz.

6 İşlem öncesi hazırlık

- Ameliyattan önce gerekli kan tahlilleri yapılır; genel anestezi uygulanacaksa anestezi uzmanı tarafından değerlendirilirsiniz/çocuğunuz değerlendirilir.
- Genel anestezi veya sedasyon uygulanacaksa ameliyattan önceki **6–8 saat** (küçük çocuklarda anestezi uzmanının belirttiği süre) boyunca bir şey yenmemeli ve içilmemelidir.
- Ameliyat sabahı saç şampuanla yıkanmalıdır. Uzun saçlar ameliyat bölgesinden uzak tutulacak şekilde toplanabilir.
- Kulak çevresinde aktif cilt enfeksiyonu, egzama veya piercing yarası varsa ameliyat ertelenebilir.
- Kullandığınız **tüm ilaçları** (kan sulandırıcılar, aspirin, ağrı kesiciler, kilo verme ilaçları, hormon ilaçları dahil), **bitkisel ürünleri ve takviyeleri** (omega-3, E vitamini, ginkgo, sarımsak, ginseng, balık yağı gibi) hekiminize bildiriniz. Hekiminizin onayı olmadan kendi kendinize hiçbir ilacı kesmeyiniz.
- Bilinen **alerjilerinizi**, kanama veya pıhtılaşma sorunlarınızı, kalp, akciğer, şeker, tansiyon, tiroid gibi hastalıklarınızı, daha önce geçirdiğiniz ameliyatları ve anesteziyle ilgili sorunları mutlaka belirtiniz.
- Hamilelik ihtimaliniz varsa veya emziriyorsanız işlemden önce mutlaka söyleyiniz.
- Sigara ve nikotin ürünleri yara iyileşmesini belirgin şekilde bozar. Mümkünse işlemden en az 2–4 hafta önce bırakmanız ve iyileşme süresince içmemeniz önerilir.

Op. Dr. Murat Ayata Muayenehanesi
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez / Kırklareli
Tel: 0288 502 50 20 · WhatsApp: 0555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

7 İyileşme süreci: sizi neler bekliyor?

İlk 48 saat	Kulaklarda zonklama, gerginlik ve orta düzeyde ağrı olabilir; ağrı kesicilerle kontrol edilir. Başınız yüksekte yatmanız önerilir. **Tek taraflı, giderek artan şiddetli ağrı normal değildir** ve hemen bildirilmelidir.
2–7. gün	Sargı genellikle **2–5. günler** arasında kontrolde açılır, kulaklar kontrol edilir. Bu dönemde kulaklarda şişlik, morarma ve hassasiyet olabilir. Sargı çıktıktan sonra yumuşak bir **saç bandı (kulak bandı)** takılmaya başlanır. Çocuklar genellikle 1 hafta sonra okula dönebilir.
1–2. haftalar	Kulak bandı ilk **1–2 hafta gece ve gündüz**, sonrasında **4–6 hafta yalnızca geceleri** takılır. Bu, uykuda kulağın katlanmasını ve dikişlerin zorlanmasını önler. Eriyen olmayan cilt dikişleri varsa 7–10. günde alınır.
3–6. haftalar	Şişlik büyük ölçüde geçer. Temas sporları, yüzme ve kulağa baskı yapabilecek kask kullanımı en az **4–6 hafta** ertelenmelidir.
3–6. aylar	Kulak kıvrımları yerine oturur, iz soluklaşır ve nihai görünüm ortaya çıkar. Kulaklardaki hafif uyuşukluk bu dönemde genellikle düzelir.

8 Olası riskler ve komplikasyonlar

Her tıbbi işlemde olduğu gibi bu işlemin de bazı riskleri vardır. Aşağıda **beklenen geçici etkiler** ile **komplikasyonlar** ayrı ayrı ve görülme sıklıklarına göre gruplandırılmıştır. Verilen oranlar bilimsel yayınlara dayanan **yaklaşık** değerlerdir; sizin kişisel riskiniz yaşınıza, genel sağlığınıza, sigara kullanımına ve daha önce geçirdiğiniz ameliyatlara göre daha düşük ya da daha yüksek olabilir.

Komplikasyonların büyük çoğunluğu **geçicidir** ve uygun tedaviyle düzelir. Listede çok nadir görülen ciddi durumlara da yer verilmiştir; bunların yazılmış olması sizde görüleceği anlamına gelmez, ancak bilgilenmiş karar verebilmeniz için bilmeniz gerekir.

Beklenen, geçici etkiler (komplikasyon sayılmaz; iyileşmenin doğal parçasıdır)

- İlk günlerde ağrı, zonklama ve gerginlik hissi
- Kulaklarda şişlik ve morarma (1–2 hafta)
- Kulak derisinde geçici uyuşukluk ve soğuğa karşı hassasiyet (haftalar–aylar)
- Kulak arkasında, zamanla soluklaşan ince iz

Sık görülen durumlar (çoğu geçicidir veya tedaviyle düzelir)

- **Dikişlerin hissedilmesi veya ciltten çıkması** — Kıkırdağı şekillendiren kalıcı dikişler, yaklaşık 100 hastadan **5–10'unda** aylar veya yıllar sonra kulak arkasından hissedilebilir, ciltten dışarı çıkabilir veya küçük bir iltihaplı kabarıklık (granülom) oluşturabilir. Genellikle basit bir işlemle dikiş alınarak düzeltilir.
- **Kısmi tekrarlama (kulağın yeniden açılması)** — Yaklaşık 100 hastadan **5–10'unda** kulak kısmen eski konumuna doğru açılabilir; gerekirse düzeltme ameliyatı yapılabilir.
- **Hafif asimetri** — İki kulak hiçbir zaman tamamen aynı değildir; ameliyat sonrası birkaç milimetrelik farklar normaldir. Belirgin fark varsa düzeltme yapılabilir.

Seyrek görülen durumlar

- **Kulakta kan toplanması (hematom)** — Yaklaşık 100 hastadan **1–3'ünde**, çoğu zaman ilk 48 saat içinde görülür. **Tek tarafta giderek artan şiddetli ağrı** en önemli belirtisidir. Kıkırdağın beslenmesini bozmadan önce **acilen boşaltılması** gerekir; geç kalınırsa kıkırdak hasarı ve kalıcı şekil bozukluğu (“karnabahar kulak”) gelişebilir.
- **Yara enfeksiyonu** — Yaklaşık 100 hastadan **1–5'inde** görülür; genellikle antibiyotikle düzelir.

Op. Dr. Murat Ayata Muayenehanesi
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez / Kırklareli
Tel: 0288 502 50 20 · WhatsApp: 0555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

- **Kalın iz veya keloid** — Yaklaşık 100 hastadan **1–3'ünde**, özellikle koyu tenlilerde ve keloid eğilimi olanlarda kulak arkasında kalın, kabarık iz gelişebilir. Kortizonlu iğne, silikon jel veya cerrahi ile tedavi gerekebilir ve tekrarlayabilir. Daha önce keloid geliştiyse lütfen bildiriniz.
- **Aşırı düzeltme veya doğal olmayan görünüm** — Kulağın başa fazla yapışık görünmesi, kıvrımın keskin olması veya kulağın orta kısmının üst ve alt kısmına göre fazla geride kalması ("telefon kulağı" görünümü) gibi durumlar olabilir; gerekirse düzeltme ameliyatı yapılır.

Nadir veya çok nadir, ancak ciddi olabilecek durumlar

- **Kıkırdak zarı iltihabı (perikondrit)** — 100 hastada **1'den az** görülür. Kulakta artan kızarıklık, şişlik, sıcaklık ve şiddetli ağrıyla belirti verir. Damar yoluyla antibiyotik tedavisi ve gerekirse cerrahi temizlik gerektirebilir; tedavi gecikirse kıkırdak kaybı ve **kalıcı şekil bozukluğu** gelişebilir.
- **Cilt veya kıkırdakta beslenme bozukluğu (nekroz)** — Çok nadirdir; çoğunlukla fazla sıkı sargı, tedavi edilmemiş hematom veya enfeksiyonla ilişkilidir. Yara bakımı ve bazen onarım ameliyatı gerekebilir.
- **Kalıcı his azalması veya kronik ağrı** — Kulak derisinde uyuşukluk veya soğukta ağrı nadiren kalıcı olabilir.
- **Dış kulak yolunda daralma** — Konka küçültme veya sabitleme sonrası çok nadiren kulak yolu girişi daralabilir; düzeltme gerekebilir.

Her cerrahi / tıbbi girişim için geçerli genel riskler

- **Anestezi riskleri:** Genel anestezi veya sedasyon uygulanacaksa riskleri (bulantı, boğaz ağrısı, diş hasarı, alerjik reaksiyon, çok nadiren kalp-akciğer sorunları) anestezi uzmanı tarafından ayrıca anlatılır ve **ayrı bir anestezi onam formu** ile onayınız alınır.
- **Kanama ve kan nakli:** Bu işlemlerde kan nakli ihtiyacı çok nadirdir. Ciddi bir kanamada kan veya kan ürünü verilmesi gerekebilir; bunun da kendine özgü (alerji, enfeksiyon gibi) çok nadir riskleri vardır.
- **Enfeksiyon:** Ameliyat sonrası yara enfeksiyonu genellikle antibiyotikle tedavi edilir; nadiren drenaj (iltihabın boşaltılması) gerekebilir.
- **Bacak toplardamarlarında pıhtı (DVT) ve akciğere pıhtı atması (pulmoner emboli):** Kısa süren baş-boyun ameliyatlarında çok nadirdir. Erken hareket etmek riski azaltır. Hormon ilacı kullanımı, sigara, obezite ve önceki pıhtı öyküsü riski artırır.
- **İlaç alerjisi:** Kullanılan ilaçlara, antiseptiklere, banda veya dikiş materyaline karşı alerjik reaksiyon gelişebilir.
- **Yara izi ve iyileşme sorunları:** Kişiden kişiye değişen iz oluşumu; çok nadiren kalın (hipertrofik) iz veya keloid gelişebilir.
- **Hayati risk:** Günümüzde planlı baş-boyun cerrahisinde ölüm son derece nadirdir; ancak hiçbir cerrahi girişimin riski tamamen sıfır değildir. Ciddi bir komplikasyon hâlinde yoğun bakım tedavisi gerekebilir ve kalıcı sakatlık gelişebilir.

Bu liste mümkün olan tüm komplikasyonları kapsamaz; tıpta öngörülemeyen, çok nadir başka durumlar da ortaya çıkabilir. Bir komplikasyon gelişirse, gerekli tedavi ve takip hekiminiz tarafından planlanır; bu durum ek tedavi, ilaç, girişim veya yeniden ameliyat gerektirebilir.

Op. Dr. Murat Ayata Muayenehanesi
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez / Kırklareli
Tel: 0288 502 50 20 · WhatsApp: 0555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

9 Hemen bize ulaşmanız gereken durumlar

- **Tek taraflı, giderek artan şiddetli kulak ağrısı** (özellikle ilk 48 saatte) — kan toplanmasının belirtisi olabilir
- Sargının içinden kan sızmasının artması veya sargının kanla ıslanması
- **38,5 °C üzerinde ateş**, kulakta artan kızarıklık, şişlik, sıcaklık veya kötü kokulu akıntı
- Sargının çok sıkı gelmesi, kulakta morarma veya renk değişikliği
- Kulağa darbe alınması veya kulağın şeklinde ani değişiklik

Bu durumlardan biri olursa bekletmeden hekiminizi arayınız: 0288 502 50 20 · WhatsApp 0555 333 21 20. Ulaşamazsanız en yakın acil servise başvurunuz veya 112'yi arayınız.

10 İlaçlar ve günlük yaşam ile ilgili öneriler

- Sargı çıkana kadar sargıyı ıslatmayınız ve kendiniz açmayınız. Sargı açıldıktan sonra hekiminizin önerdiği günden itibaren nazikçe duş alınabilir.
- Kulak bandını size söylenen süre boyunca düzenli takınız; bu, sonucun kalıcılığı için önemlidir.
- İlk haftalarda kulakların üzerine yatmaktan, kulağı öne doğru katlamaktan ve dar yakalı kıyafetleri kulakları zorlayarak giyip çıkarmaktan kaçınınız.
- Kulakları en az 3 ay güneşten ve aşırı soğuktan koruyunuz; his azlığı nedeniyle yanık veya donma fark edilmeyebilir.
- Çocuğunuzun sargıyı veya bandı çekmemesi için gerekli gözetimi sağlayınız.
- Size reçete edilen ilaçları (antibiyotik, ağrı kesici vb.) önerilen doz ve sürede kullanınız. Aspirin ve benzeri kanamayı artırabilecek ilaçları hekiminize danışmadan kullanmayınız.
- Ameliyat sonrası 4 saatten uzun uçak veya kara yolculuğunda bol su için, sık sık hareket edin ve önerildiyse varis çorabı kullanın; bu, bacakta pıhtı riskini azaltır.
- İyileşme sürecinde alkol almamanız, sigara ve nikotin ürünlerinden uzak durmanız önerilir.
- Kontrol randevularınıza mutlaka geliniz. Yurt dışından geldiyseniz dönüşünüzden sonra kontroller online görüşme ve fotoğraf/video ile sürdürülebilir; yerel bir hekime başvurmanız gerekirse size ameliyat raporu ve önerilerimiz yazılı olarak verilir.

11 İşlem sırasında beklenmeyen durumlar, doku örnekleri ve kan ürünleri

İşlem sırasında önceden öngörülemeyen bir durumla karşılaşılırsa, hekiminiz yalnızca bu formda onay verdiğiniz işlemin kapsamında kalır. **Hayati tehlike veya ciddi organ zararı riski** olmadıkça onay vermediğiniz ek bir işlem yapılmaz; böyle bir durumda işlem uygun noktada sonlandırılır ve size sonradan bilgi verilerek karar birlikte alınır. Hayati tehlike durumunda ise hayatınızı veya organınızı korumak için gerekli acil müdahale yapılır.

İşlem sırasında çıkarılan dokular, gerekli görüldüğünde tanının kesinleştirilmesi için **patolojik incelemeye** gönderilir. Bu inceleme sonucuna göre ek tedavi veya takip gerekebilir.

Kan nakli ihtiyacı bu işlemlerde çok nadirdir; yalnızca hayati gerekliliği olan durumlarda uygulanır. Kan veya kan ürünü almayı kabul etmiyorsanız (örneğin inanç nedeniyle) bunu işlemden önce mutlaka bildiriniz; bu kararın olası sonuçları sizinle ayrıca konuşulur ve “Size özel bilgiler” bölümüne yazılır.

12 Fotoğraf, görüntü kayıtları ve kişisel verileriniz

Tedavinizin planlanması, takibi ve sonucun değerlendirilmesi amacıyla işlem öncesinde ve sonrasında **fotoğraf/video** çekilebilir. Bu kayıtlar sağlık dosyanızın parçasıdır ve gizli tutulur. Görüntüleriniz **hiçbir koşulda reklam, tanıtım veya sosyal medya amacıyla kullanılmaz.**

Görüntülerinizin bunun dışındaki amaçlarla kullanılması **yalnızca sizin ayrı ve açık izninizle** mümkündür. İzin vermemeniz tedavinizi hiçbir şekilde etkilemez ve verdiğiniz izni dilediğiniz zaman geri alabilirsiniz:

☐ Görüntülerimin yalnızca **tıbbi kayıt ve tedavi takibi** amacıyla kullanılmasını kabul ediyorum.

Op. Dr. Murat Ayata Muayenehanesi
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez / Kırklareli
Tel: 0288 502 50 20 · WhatsApp: 0555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

☐ Görüntülerimin **kimliğim anlaşılmayacak şekilde** (yüz/göz bölgesi kapatılarak) bilimsel yayın ve hekim eğitimi amacıyla kullanılmasına izin veriyorum.

☐ Görüntülerimin **kimliğim anlaşılabilecek şekilde** bilimsel yayın ve hekim eğitimi amacıyla kullanılmasına izin veriyorum.

☐ Bilimsel/eğitim amaçlı kullanıma **izin vermiyorum.**

Kişisel ve sağlık verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sağlık mevzuatı kapsamında, tanı, tedavi ve yasal yükümlülükler amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altındaki kişilerce işlenir. Ayrıntılı bilgi için KVKK Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz.

13 Size özel bilgiler ve notlar (hekim tarafından doldurulur)

Hastaya özgü ek riskler (eşlik eden hastalıklar, kullanılan ilaçlar, önceki ameliyatlar), planın ayrıntıları, hastanın beklentisi, sorduğu sorular ve verilen cevaplar. Boş kalacaksa "yoktur" yazılır.

14 Hasta beyanı

☐ Bu formu kendi dilimde okudum, anladım. Yeterli düşünme süresi tanındı; sorularımı sorma fırsatı buldum ve tatmin edici yanıtlar aldım.

☐ Durumum, önerilen işlemin amacı, nasıl yapılacağı, kim tarafından ve nerede yapılacağı, tahmini süresi, beklenen faydaları, başarı şansı, alternatifleri ve işlem yapılmazsa olabilecekler bana sözlü ve yazılı olarak açıklandı.

☐ Sık görülen ve ciddi olabilecek riskler ile bu komplikasyonların olası sonuçları (ek tedavi, yeniden işlem/ameliyat gerekebileceği dahil) bana anlatıldı. Tıpta hiçbir işlemin sonucunun **%100 garanti edilemeyeceğini** biliyorum.

☐ Sağlık durumum, kullandığım ilaçlar, alerjilerim ve geçirdiğim hastalıklar hakkında doğru ve eksiksiz bilgi verdim. Eksik veya yanlış bilgi vermemin riskleri artırabileceğini biliyorum.

☐ İşlem öncesi ve sonrasında verilecek talimatlara uymamın sonucun bir parçası olduğunu ve kontrol randevularına gelmenin önemini anladım.

☐ Onayımı işlem başlamadan önce istediğim zaman geri alabileceğimi biliyorum. Bu formu imzalamamın, hekimin özen yükümlülüğünü ortadan kaldırmadığını biliyorum.

☐ Bu kararı kimsenin baskısı olmadan, kendi özgür irademle veriyorum.

☐ Ameliyattan sonra kulak bandının önerilen süre boyunca takılmasının sonucun bir parçası olduğunu ve bu talimatlara uyulmamasının tekrarlama riskini artırabileceğini anladım.

☐ Bu işlemin **estetik amaçlı** olduğunu, tıbben zorunlu olmadığını ve yaptırmama seçeneğimin her zaman bulunduğunu biliyorum. Beklentilerimi hekimimle konuştum; ulaşılabilecek gerçekçi sonuç bana anlatıldı.

☐ Kusursuz simetri veya bir fotoğraftaki görünümün aynısının garanti edilemeyeceğini, nihai sonucun dokularımın iyileşme özelliklerine bağlı olduğunu ve bazı durumlarda düzeltme işlemi gerekebileceğini anladım.

☐ **Yukarıda açıklanan işlemin bana uygulanmasına ONAY VERİYORUM.**

☐ **Yukarıda açıklanan işlemi KABUL ETMİYORUM. Reddetmenin olası sonuçları bana anlatıldı.**

Hasta tarafından kendi el yazısıyla yazılması önerilir: "Bu formu okudum, anladım, onay veriyorum."

Op. Dr. Murat Ayata Muayenehanesi
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez / Kırklareli
Tel: 0288 502 50 20 · WhatsApp: 0555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

15 İmzalar

	ADI SOYADI	İMZA	TARİH / SAAT
Hasta			
Yasal temsilci (veli / vasi) — yakınlığı:			
Bilgilendiren ve işlemi yapacak hekim			
Tercüman (gerekirse) — dil:			
Tanık (gerekirse)			

Tercüman beyanı: Bu formu ve hekimin sözlü açıklamalarını hastaya / yasal temsilciye eksiksiz ve doğru olarak, anladığı dilde tercüme ettim.

18 YAŞINDAN KÜÇÜK VEYA KARAR VERME YETİSİ KISITLI HASTALAR İÇİN

18 yaşından küçük hastalarda onam, **veli veya vasi** tarafından verilir. Çocuk, yaşı ve olgunluğuyla uyumlu biçimde bilgilendirilir ve görüşü alınır. Kısıtlı hastalarda onamı yasal temsilci verir.

☐ Velayeti birlikte kullanıyorsak, diğer ebeveynin de bu işlemden haberdar olduğunu ve onay verdiğini beyan ederim.

☐ Velayet / vesayet konusunda bir mahkeme kararı veya anlaşmazlık bulunmadığını beyan ederim (varsa hekime belgesi gösterilmiştir).

Çocuğun yaşına uygun şekilde bilgilendirildiği ve görüşü: _____

Bu form iki nüsha olarak düzenlenmiştir: bir nüshası hasta dosyasında saklanır, bir nüshası hastaya / yasal temsilciye verilir.

ONAMIN GERİ ALINMASI (YALNIZCA VAZGEÇİLMESİ HÂLİNDE DOLDURULUR)

Yukarıda verdiğim onayı geri alıyorum. Vazgeçmemin olası sonuçları bana açıklandı.

Vazgeçen hasta/temsilci adı soyadı, imza, tarih, saat: _____

Bu form, T.C. Hasta Hakları Yönetmeliği ve Türk Tabipleri Birliği Aydınlatılmış Onam ilkeleri esas alınarak hazırlanmıştır. Sözlü bilgilendirmenin yerini tutmaz, onu tamamlar.